

保育園、 いつから行ける？

医師が解説

子どもの夏の感染症

手足口病・ヘルパンギーナ・プール熱・とびひ



医知創造ラボ

© 2026 医知創造ラボ





日数が決まっているのは プール熱 だけ



1

プール熱…

法律で出席停止の日数が決まっている

2

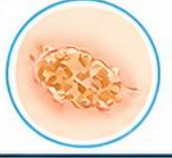
手足口病・ヘルパンギーナ・とびひ…

日数の決まりなし

3

→ 元気が戻れば
登園できるのが基本

夏の感染症 登園の早見表

病気	原因	分類	登園の目安
 手足口病	ウイルス	第三種	熱が下がり普段通り 食べられれば可（発疹が残ってもOK）
 ヘルパンギーナ	ウイルス	第三種	熱が下がり普段通り 食べられれば可
 プール熱	ウイルス	第二種	主な症状が消えて 2日 たつまで休む
 とびひ	細菌	第三種	患部を覆えれば登園可／ プールは治るまで不可

※登園許可証・登園届の可否は自治体・園で異なります



医知創造ラボ

3 / 15

① 手足口病



手のひらに発疹



多くは5歳以下 /
1週間ほどで自然に軽快



口の中に発疹



足のうらに発疹





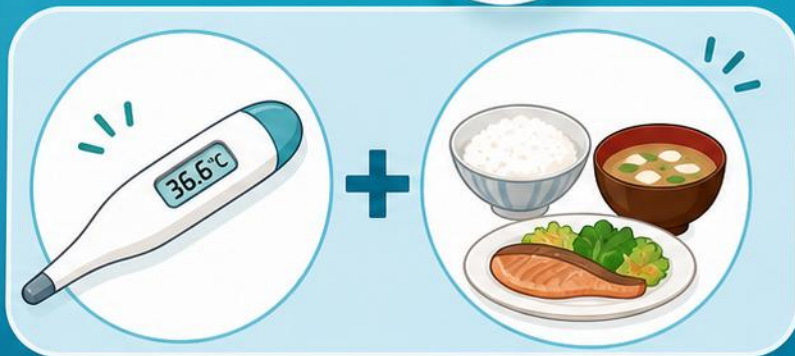
手足口病の登園

発疹が残ってもOK

熱が下がり、普段通り食べられれば登園可

✓ 発疹だけで休む必要はありません

✓ 全身状態を見て判断



まれに重い合併症



受診すべき
サイン



髄膜炎・脳炎などに注意



水分がとれない



ぐったりしている



強い頭痛



繰り返す嘔吐



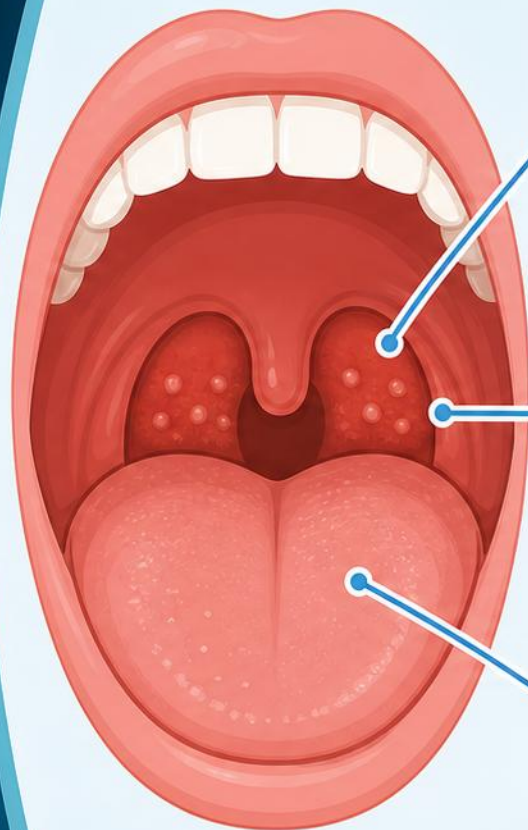
けいれん



医知創造ラボ

6 / 15

② ヘルパンギーナ 突然の高熱 + のどの奥の水疱



のどの奥に
小さな**水疱**



乳幼児に多い
夏かぜ



強いのどの痛みで
食べにくい



手足口病との違い

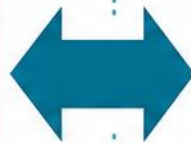
手足口病



- 手・足・口
に発疹



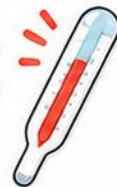
- 熱は軽め
のことも



ヘルパンギーナ



- のどの奥に
水疱



- 突然の
高熱が多い



違い = 発疹の場所と熱の高さ



③ プール熱

発熱・のど・目の充血

アデノウイルスによる感染症

発熱



のどの痛み



目の充血



第二種



主な症状が消えて 2日休む



法律で出席停止の期間が決まっています



発熱・のど・目の症状が消えてから



症状あり

発熱・のど・目の症状



症状消失

発熱・のど・目の症状
が消えた



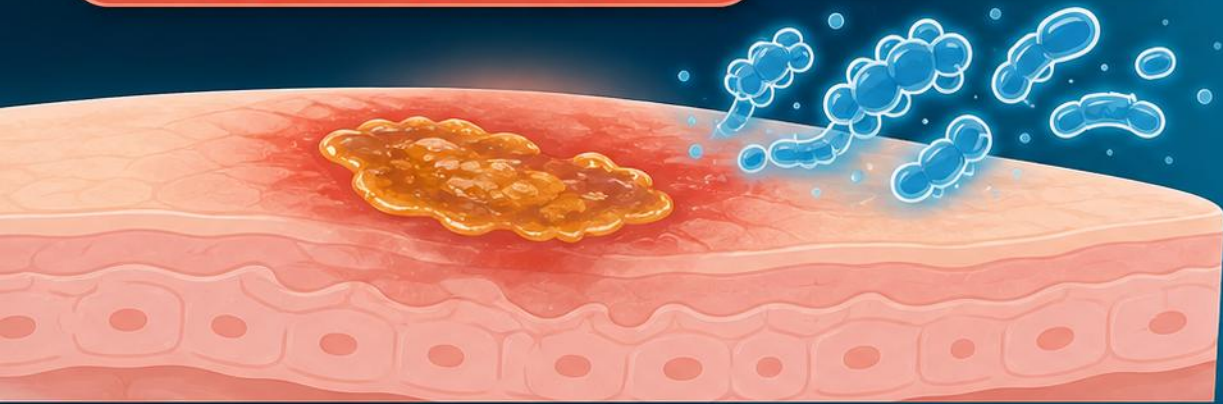
症状が消えて
2日間は休む



登園

登園できます

④ とびひ 4つで唯一の “細菌”感染



皮ふの
傷から広がる



かきこわして
うつりやすい



抗菌薬で治療

とびひの登園

患部を覆えれば
登園可



ガーゼ・包帯で覆う

プールは
治るまで不可

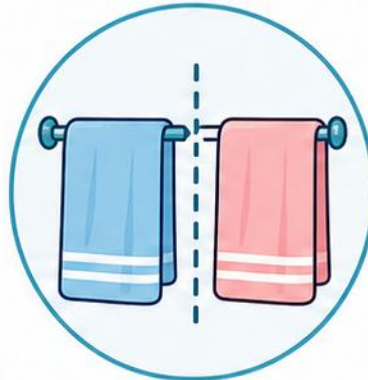


じゅくじゅくが治るまで

家庭でできるケア・予防



手洗い



タオルを
分ける



水分を
こまめに



爪を短く

⚠ 受診の危険サイン

迷ったら早めに相談



水分がとれない



ぐったり



繰り返す嘔吐



けいれん



息が苦しそう



症状が強い・長引く場合は医療機関へ



医知創造ラボ

14 / 15

まとめ



登園は “日数”より 全身状態



病気	登園の目安
 手足口病	熱が下がり食べられれば可
 ヘルパンギーナ	熱が下がり食べられれば可
 プール熱	主な症状が消えて 2日
 とびひ	患部を覆えれば可



高評価・チャンネル登録をお願いします



医知創造ラボ

15 / 15